



PROTOCOLO — PRONTO-SOCORRO NATAL DIEGUES

Prefeitura Municipal de Estiva Gerbi / SP • Secretaria Municipal de Saúde

Série de protocolos institucionais de urgência e emergência — uso interno da equipe médica

Protocolo de Enfermagem — Acolhimento com Classificação de Risco e Condutas Delegadas na Triage do PS Natal Diegues

Sinais vitais e gatilhos, classificação em 5 níveis, o que a enfermagem faz antes do médico (por protocolo institucional) em cada síndrome, o que não faz, quando aciona o médico e o que registra — companheiro dos 36 protocolos médicos da série

Código	PS-ND-ENF-01	Versão	1.0 (minuta)
Elaboração	Felipe Ribeiro Toledo — Médico — CRM-SP 216.986	Data-base	setembro/2026
Aprovação (Diretor Clínico)	_____	Vigência	___/___/___
Aprovação (Coordenação PS)	_____	Revisão prevista	___/___/___

0. Finalidade, base legal e regras gerais

Os 36 protocolos médicos desta série repetem uma constatação: **os minutos que decidem o desfecho ocorrem antes do médico** — glicemia no rebaixamento, ECG na dor torácica, adrenalina na anafilaxia, cronômetro na convulsão, analgesia na fratura, lavagem na mordedura, tiamina no etilista. Este protocolo formaliza o que a equipe de enfermagem faz **na triagem e na sala de emergência, por protocolo institucional aprovado**, para que esses minutos não se percam. Ele não substitui a avaliação médica: **antecipa** medidas de baixo risco e alto impacto, define gatilhos objetivos de acionamento e padroniza o registro.

Base legal e normativa: Lei nº 7.498/1986, art. 11 (privativo do enfermeiro: consulta e prescrição de enfermagem; art. 11, II, "c": prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e **em rotina aprovada pela instituição de saúde**) e Decreto 94.406/1987; **Resolução COFEN nº 661/2021** (classificação de risco é atividade privativa do enfermeiro, com protocolo institucional); **Resolução COFEN nº 736/2024** (Processo de Enfermagem — histórico, diagnóstico, planejamento, implementação, avaliação); Resolução COFEN nº 427/2012 (contenção); Resolução COFEN nº 564/2017 (Código de Ética); Portaria GM/MS nº 2.048/2002 (urgências — acolhimento com classificação de risco); Política Nacional de Humanização — *Acolhimento e Classificação de Risco nos Serviços de Urgência* (MS, 2009); Sistema Manchester de Classificação de Risco (Grupo Brasileiro de Classificação de Risco) como referência de discriminadores; Portaria GM/MS nº 1.271/2014 (notificação compulsória). **Este protocolo só entra em vigor com aprovação escrita do Diretor Clínico e do Responsável Técnico de Enfermagem (COREN-SP)** — campos na capa.

Regra geral	Detalhe
Quem faz	Classificação de risco e prescrição de enfermagem: enfermeiro ; execução de medidas e administração: enfermeiro ou técnico sob supervisão, conforme competência e este protocolo; toda conduta delegada é registrada como "conforme protocolo institucional PS-ND-ENF-01, item X"
O que pode ser feito antes do médico	Somente o que está listado nas fichas da seção 3, nas doses e condições ali escritas; qualquer situação fora do escrito → acionar o médico e não administrar
Checação obrigatória antes de qualquer medicamento delegado	Alergia (perguntar e olhar pulseira/prontuário), gestação (idade fértil: perguntar; β -hCG se dúvida antes de AINE/opioide), peso (criança: sempre; adulto: estimar), DRC/úlcera/sangramento/anticoagulante (antes de AINE), medicamentos em uso, o que já tomou hoje (dose máxima), sinais vitais registrados

Regra geral	Detalhe
Reavaliação	Toda classificação tem tempo máximo para o médico e intervalo de reavaliação de enfermagem; toda medicação delegada tem reavaliação em 30 min (IV/IM) ou 60 min (VO) com registro da resposta (escala)
Acionamento do médico	Imediato (à beira-leito, interrompendo o que faz) para VERMELHO e para os gatilhos marcados Δ ; em ≤ 10 min para LARANJA; os demais pela fila com prioridade. Registrar hora do acionamento e hora da chegada do médico
O que a enfermagem não faz	Diagnóstico médico; dar alta; medicar fora do protocolo; "deixar para ver se melhora" sem reavaliação marcada; classificar pelo tempo de espera ou pela pressão da fila; rebaixar classificação por falta de leito
Registro mínimo (todo paciente)	Hora de chegada, hora da triagem, queixa nas palavras do paciente, sinais vitais completos, escala de dor, classificação (cor) e discriminador, condutas delegadas (item, dose, hora, quem), hora de acionamento do médico, reavaliações com hora

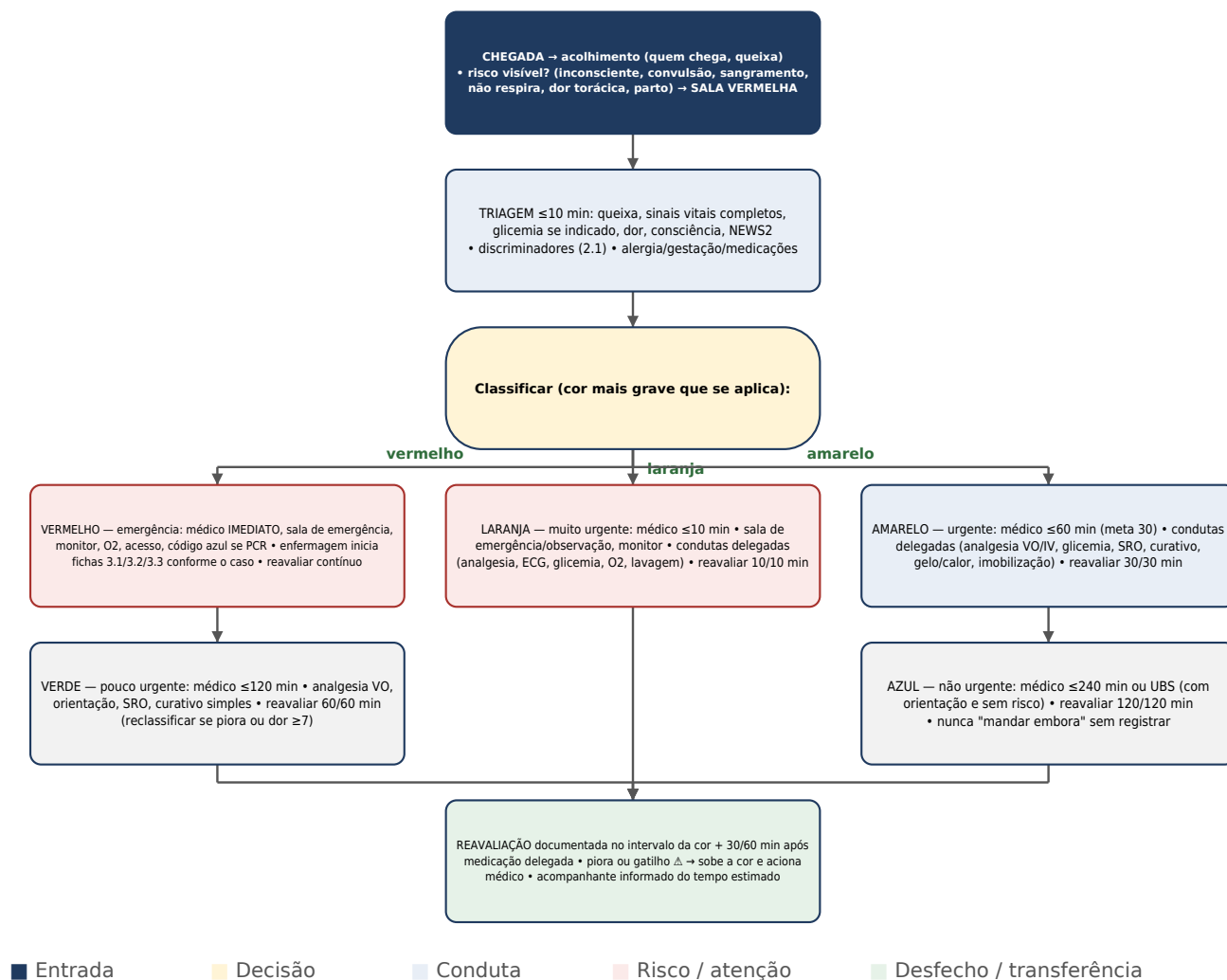
1. Sinais vitais na triagem — o mínimo, os limites e os gatilhos

Parâmetro	Sempre medir	Gatilho Δ (acionar médico imediatamente e classificar LARANJA/VERMELHO)
Pressão arterial (manguito adequado, sentado, após 5 min de repouso se possível; nos dois braços se dor torácica/dorsal)	Todos ≥ 3 anos	PAS < 90 ou > 220 / PAD > 120 ; PAS < 100 com FC > 100 ou sintomas; diferença > 20 mmHg entre braços
Frequência cardíaca (pulso por 1 min; regularidade)	Todos	< 50 ou > 120 (criança: por idade); irregular com sintomas
Frequência respiratória (contar 1 min — nunca estimar)	Todos	Adulto < 10 ou > 24 (≥ 30 = grave); criança: < 2 m ≥ 60 , 2-11 m ≥ 50 , 1-5 a ≥ 40 , > 5 a ≥ 30 ; esforço/tiragem/gemência
SpO ₂ em ar ambiente (antes de O ₂ ; registrar se em uso de O ₂)	Todos	$< 92\%$ (DPOC conhecido: $< 88\%$); $< 95\%$ com dispneia ou síndrome gripal (SRAG)
Temperatura	Todos	< 35 ou $\geq 39,5$ °C; ≥ 38 em < 3 meses, imunossuprimido, quimioterapia, pós-operatório, com hipotensão/confusão
Glicemia capilar	Todo rebaixamento/confusão/agitação/convulsão/sudorese/diabético/etilista/criança letárgica	< 70 ou > 250 com sintomas (> 400 sempre)
Nível de consciência (AVDN/Glasgow) e pupilas	Todos	Não alerta (V, D, N); Glasgow < 15 novo; anisocoria
Escala de dor (0-10; faces; FLACC; PAINAD)	Todos com dor	Dor ≥ 7 (laranja) — analgesia por protocolo + médico ≤ 10 min
Peso (criança: sempre; adulto: estimado)	Crianças; adultos para doses	—
Perfusão (TEC, pele), edema, sinais de desidratação (criança)	Todos	TEC > 3 s, pele fria/marmórea; desidratação grave (Plano C)

Escore de alerta (NEWS2 simplificado — somar): FR (≤ 8 : 3; 9-11: 1; 12-20: 0; 21-24: 2; ≥ 25 : 3) • SpO₂ (≤ 91 : 3; 92-93: 2; 94-95: 1; ≥ 96 : 0) • O₂ suplementar (2) • PAS (≤ 90 : 3; 91-100: 2; 101-110: 1; 111-219: 0; ≥ 220 : 3) • FC (≤ 40 : 3; 41-50: 1; 51-90: 0; 91-110: 1; 111-130: 2; ≥ 131 : 3) • consciência (não alerta: 3) • T (≤ 35 : 3; 35,1-36: 1; 36,1-38: 0; 38,1-39: 1; $\geq 39,1$: 2). **≥ 5 (ou 3 em um parâmetro) = LARANJA + sepse? (ficha 3.4); ≥ 7 = VERMELHO.** Registrar o escore na triagem e a cada reavaliação.

2. Acolhimento com classificação de risco — fluxo e discriminadores

Toda pessoa é acolhida na chegada (quem é, o que sente, em uma frase) e classificada em **≤10 min**. A cor define o **tempo máximo para o médico**, o **intervalo de reavaliação** e **quais condutas delegadas** a enfermagem inicia. A cor nunca é rebaixada por falta de leito; é elevada sempre que um gatilho ⚠ aparece.



2.1 Discriminadores por cor (adaptados do Manchester/PNH aos protocolos da série)

Cor / tempo	Discriminadores (qualquer um)	Protocolos
VERMELHO — imediato	Via aérea comprometida/estridor; parada ou FR <10 ou >35; SpO ₂ <85%; choque (PAS <90 + hipoperfusão); inconsciente (D/N); convulsão em curso; hemorragia exsanguinante; anafilaxia (urticária + dispneia/hipotensão); dor torácica com instabilidade/ECG com supra; déficit neurológico agudo (FAST +) com LSN <24 h; hipoglicemia <50 com rebaixamento; queimadura de face/inalação; trauma maior com instabilidade; parto iminente; criança letárgica/cianótica/com desidratação grave; agitação com risco iminente de violência; NEWS2 ≥7	30, 12, 01, 03, 13, 14, 34, 28, 04, 06
LARANJA — ≤10 min	Dor torácica (qualquer, >30 anos ou com fatores de risco); dispneia moderada (SpO ₂ 85–91%, FR 25–35, fala frases curtas); dor intensa ≥7/10; febre ≥39,5 ou ≥38 com hipotensão/confusão/imunossupressão/<3 meses; NEWS2 ≥5; suspeita de sepse (2 de: FR ≥22, PAS ≤100, confusão + infecção); síncope; cefaleia súbita/"pior da vida"/com rigidez de nuca; sangramento ativo moderado/hematêmese/melena; hiperglicemia >400 ou CAD suspeita; hipoglicemia <70 sintomática; crise convulsiva recente (pós-ictal); dor abdominal intensa/abdome rígido/vômitos com sangue; cólica renal intensa; trauma craniano com vômitos/anticoagulante/≥65 a/PC; queimadura >10% ou área especial; mordedura/animal peçonhento; intoxicação; abstinência com tremor/sudorese/agitação; violência sexual ≤72 h; gestante com PA ≥160/110/sangramento/dor; dengue com sinal de alarme; idoso >80 com queda; escorpião em criança <10 a; ideação suicida com plano	01, 07, 16, 36, 05, 25, 32, 22, 02, 13, 14, 20, 21, 29, 28, 27, 23, 31, 35, 15, 11
AMARELO — ≤60 min (meta 30)	Dor moderada 4–6; febre <39,5 sem sinais de gravidade; vômitos/diarreia com desidratação leve-moderada (Plano B); dispneia leve com SpO ₂ ≥92%; PA ≥180/120 assintomática; cefaleia habitual intensa; dor abdominal moderada; lombalgia sem red flags com dor intensa; celulite/abscesso; TCE leve sem critério; ferida que precisa de sutura; crise de asma leve/moderada; dengue sem alarme com comorbidade; cólica renal leve; agitação leve/ansiedade; idoso com queixa inespecífica; criança <1 ano com febre	36, 06, 15, 32, 20, 33, 26, 29, 07, 11, 21, 04
VERDE — ≤120 min	Dor leve 1–3; sintomas gripais sem alarme; diarreia sem desidratação (Plano A); lesões pequenas; troca de curativo; dor crônica sem mudança; ITU sem febre; lombalgia leve	06, 08, 33, 36
AZUL — ≤240 min / UBS	Queixas administrativas, receitas, resultados, sintomas crônicos estáveis sem piora, sem sinais vitais alterados	—

Populações com **classificação uma cor acima** do discriminador quando em dúvida: <1 ano e >80 anos; gestante; imunossuprimido; anticoagulado; diabético com qualquer intercorrência; pessoa com deficiência/limitação de comunicação; retorno em 24–48 h pela mesma queixa; "não parece bem" (impressão do enfermeiro — registrar).

3. Fichas de condutas delegadas — o que a enfermagem faz antes do médico

Cada ficha traz: **gatilho** (quando se aplica), **faz** (por protocolo, com dose e condição), **não faz**, **aciona médico** (quando e como) e **registra**. As doses seguem os protocolos médicos correspondentes (número entre colchetes). Em criança, toda dose é por peso e conferida com a tabela/fita de Broselow afixada; na dúvida, não administrar e acionar.

3.1 Parada cardiorrespiratória — código azul [30]

Gatilho	Sem resposta + sem respiração normal (gaspings conta como ausente) + sem pulso em ≤ 10 s
Faz	Acionar o código (ramal/campainha ____) e o desfibrilador; compressões imediatas 100–120/min, 5–6 cm, 30:2 com BVM + O ₂ (criança 15:2 com 2 socorristas); pás adesivas/DEA: analisar e chocar se indicado (DEA) sem esperar o médico ; acesso IV/IO; preparar adrenalina 1 mg (criança 0,01 mg/kg); registrador com cronômetro (hora da PCR, choques, drogas a cada 2 min); trocar compressor a cada 2 min; papéis: líder (médico ao chegar), compressor 1/2, via aérea, desfibrilador, drogas, registro
Não faz	Interromper compressões >10 s; ventilar excessivamente; administrar drogas sem prescrição verbal do médico (exceto conforme fluxo de DEA/ACLS institucional aprovado)
Aciona	Médico imediato; SAMU se médico ausente; família: acolhimento por profissional designado
Registra	Formulário Utstein: hora de reconhecimento, 1ª compressão, 1º choque, ritmo, drogas/horas, RCE, ETCO ₂ , quem participou; debriefing

3.2 Dor torácica / suspeita de SCA [01]

Gatilho	Dor/desconforto torácico, epigástrico, dorsal ou em MSE; dispneia ou síncope inexplicada em >40 anos/diabético/cardiopata
Faz	ECG de 12 derivações em ≤ 10 min da chegada (antes da consulta) e entregar ao médico imediatamente; monitor, SpO ₂ , PA nos 2 braços, acesso venoso, glicemia; O ₂ só se SpO ₂ <90%; repouso; se ECG com supra de ST/paciente instável → sala vermelha; AAS 200–300 mg mastigado por protocolo se dor típica, sem alergia, sem sangramento ativo, sem suspeita de dissecação (dor lacerante/assimetria de PA) — registrar; coletar troponina se protocolo laboratorial
Não faz	Nitrato, morfina, anticoagulante, clopidogrel sem prescrição; IM (interfere na CPK e contraindica fibrinólise); liberar para a fila sem ECG lido
Aciona	Médico ≤ 10 min (laranja); imediato se supra de ST, instabilidade, dor persistente ≥ 7
Registra	Hora do início da dor, hora do ECG, escala de dor, AAS (dose/hora), PA nos 2 braços

3.3 Déficit neurológico agudo — código AVC [03]

Gatilho	FAST/BE-FAST positivo (face, braço, fala, equilíbrio/visão) de início súbito, ou confusão/rebaixamento súbitos
Faz	Perguntar e anotar a hora em que foi visto normal pela última vez (LSN) ; glicemia capilar (corrigir <60 conforme 3.6); SpO ₂ (O ₂ se <94%); PA (não tratar); 2 acessos; monitor; cabeceira 0–30°; jejum absoluto (inclusive comprimidos); NIHSS se treinado; acionar médico e, por ordem médica, a regulação/tele-AVC — ou, se protocolo institucional, acionar a regulação já ao reconhecer (código AVC)
Não faz	Dar nada VO; baixar a PA; esperar exames para acionar; sondar sem indicação
Aciona	Médico imediato (vermelho se LSN <24 h)
Registra	LSN (hora), hora da chegada, FAST/NIHSS, glicemia, PA, medicações em uso (anticoagulante — hora da última dose)

3.4 Suspeita de sepse [05]

Gatilho	Infecção suspeita + 2 de: FR ≥22, PAS ≤100, confusão nova; ou NEWS2 ≥5; ou T ≥38/<36 com FC >90 e FR >20
Faz	Laranja/vermelho; monitor; 2 acessos; coletar lactato e 2 hemoculturas (antes do antibiótico) + exames do pacote sepse se protocolo laboratorial; SpO ₂ (O ₂ se <92%); preparar cristalóide (30 mL/kg se PAS <100/lactato ≥2 — iniciar por ordem médica); iniciar cronômetro do pacote de 1 h; separar antibiótico do protocolo para o foco provável (não administrar sem prescrição)
Não faz	Atrasar culturas esperando o médico; administrar antibiótico sem prescrição; usar acesso único fino
Aciona	Médico ≤10 min (imediato se PAS <90/confusão); meta: antibiótico ≤1 h da triagem
Registra	Hora do reconhecimento ("hora zero"), NEWS2, culturas (hora), lactato, volume iniciado, hora do antibiótico

3.5 Anafilaxia [12]

Gatilho	Urticária/angioedema de início súbito + (dispneia/sibilo/estridor OU hipotensão/síncope OU vômitos/cólica intensos) após alimento/medicamento/picada — ou hipotensão/broncoespasmo súbitos após exposição conhecida
Faz	ADRENALINA 1 mg/mL IM na face lateral da coxa: adulto 0,5 mg (0,5 mL); criança 0,01 mg/kg (máx. 0,3 mg <30 kg / 0,5 mg ≥30 kg) — por protocolo, imediatamente, sem esperar o médico; deitar com pernas elevadas (sentar se dispneia); remover o alérgeno (parar infusão, retirar ferrão); O ₂ alto fluxo; acesso calibroso; SF 0,9% 20 mL/kg pronto (adulto 1 L) — infundir se PAS <90 por ordem médica ou protocolo; repetir adrenalina em 5–15 min se sem melhora (ordem médica); preparar anti-H1/corticoide (2ª linha, só após adrenalina)
Não faz	Anti-histamínico ou corticoide antes/em vez da adrenalina; deixar sentar/levantar bruscamente; adrenalina IV/SC
Aciona	Médico imediato (vermelho)
Registra	Alérgeno/via/hora, hora da adrenalina (dose, sítio), sinais vitais a cada 5 min, resposta

3.6 Hipoglicemia [13]

Gatilho	Glicemia <70 mg/dL (ou sintomas: sudorese, tremor, confusão, convulsão em diabético/etilista)
Faz	Consciente e deglute: 15 g de carboidrato VO (1 colher de sopa de açúcar em ½ copo d'água, 150 mL de suco, ou gel) — repetir glicemia em 15 min e a dose se <70; lanche depois. Rebaixado/não deglute: acesso → glicose 50% 20-40 mL IV lenta (criança: G10% 2-5 mL/kg — não G50%); etilista/desnutrido: tiamina 300 mg IV antes ou junto; sem acesso: glucagon 1 mg IM/SC (0,5 mg <25 kg) — por protocolo; decúbito lateral; glicemia a cada 15 min até >100
Não faz	Dar VO a rebaixado; G50% em criança; liberar após 1 correção sem médico (sulfonilureia/insulina longa exigem observação)
Aciona	Médico ≤10 min (imediato se convulsão/coma/sem melhora em 15 min)
Registra	Glicemias seriadas com hora, o que foi dado (via/dose/hora), hipoglicemiante em uso (nome/dose/hora da última)

3.7 Crise convulsiva [14]

Gatilho	Convulsão em curso ou recém-cessada
Faz	Cronômetro (hora do início); proteger (afastar objetos, não conter membros, nada na boca), decúbito lateral, aspirar, O ₂ ; glicemia capilar (corrigir se <70 — 3.6); acesso; monitor; se ≥5 min de crise (ou 2ª crise sem recuperar) e médico ainda não chegou: diazepam 10 mg IV lento (criança 0,15-0,2 mg/kg, máx. 10 mg) ou midazolam 10 mg IM (>40 kg; 5 mg 13-40 kg; criança 0,2 mg/kg máx. 10 mg) — por protocolo, com o médico acionado; preparar 2ª linha (fenitoína/levetiracetam) para prescrição; gestante ≥20 sem: avisar que é possível eclâmpsia (MgSO ₄)
Não faz	Conter membros; introduzir objetos na boca; medicar crise que já cessou; fenitoína sem monitor e velocidade prescrita
Aciona	Médico imediato (vermelho se em curso; laranja se pós-ictal)
Registra	Hora do início/fim, semiologia (lado, olhos, tipo), glicemia, BZD (dose/via/hora), recuperação (Glasgow seriado)

3.8 Dispneia / asma / DPOC / síndrome gripal [07, 16, 06, 10]

Gatilho	Dispneia, sibilância, tosse com esforço, SpO ₂ <95%
Faz	Sentar; SpO ₂ em ar ambiente e FR/1 min; O ₂ titulado: alvo 92-95% (asma/geral); 88-92% se DPOC conhecido — nunca alto fluxo cego; asma/sibilância conhecida: salbutamol pMDI 100 mcg com espaçador 4-8 jatos (criança ≤5 a: 2-6 jatos) por protocolo, repetir a cada 20 min até 3x com reavaliação de SpO₂/FR entre as séries; peak flow se disponível; máscara cirúrgica se síndrome gripal (isolamento); gasometria se protocolo laboratorial em DPOC/SpO ₂ <92%; preparar corticoide/ipratrópio para prescrição
Não faz	O ₂ a 10-15 L/min em DPOC sem indicação; nebulização com O ₂ alto em DPOC; corticoide/antibiótico sem prescrição; deitar o paciente dispneico
Aciona	Imediato se SpO ₂ <85%, tórax silencioso, sonolência, fala monossilábica, FR >30/<10; ≤10 min se SpO ₂ 85-91%/esforço; ≤30 min se leve
Registra	SpO ₂ ar ambiente e com O ₂ (fluxo), FR, jatos/horários, PFE, resposta

3.9 Dor — analgesia na triagem [36]

Gatilho	Dor ≥4/10 (moderada/intensa) sem sinais de gravidade que exijam sala vermelha primeiro
Faz (após checagem de alergia/g estação/DRC /úlcera/antic oagulante/m edicações)	Adulto: dipirona 1 g VO (ou paracetamol 750 mg) para dor 4-6; + ibuprofeno 400 mg VO se musculoesquelética/cólica e sem contraindicação; dor ≥7: dipirona 1-2 g IV diluída (lenta) + acionar médico ≤10 min para opioide/AINE IV. Criança >3 meses: dipirona 15 mg/kg VO/IV ou paracetamol 15 mg/kg; ibuprofeno 10 mg/kg (>6 meses) se musculoesquelética. Medidas: imobilizar/elevar (fratura, entorse), frio nas primeiras 48 h de trauma, calor em cólica/muscular, posição de conforto, ambiente calmo; fratura evidente: imobilizar antes do RX. Reavaliar em 30 min (IV) / 60 min (VO) e registrar a escala
Não faz	Injeção IM de analgésico de rotina (só se protocolo específico — ex.: diclofenaco 75 mg IM na cólica renal típica sem contraindicação); opioide, tramadol, relaxante, benzodiazepínico sem prescrição; AINE em gestante/DRC/úlcera/anticoagulado/idoso desidratado; repetir dose antes da reavaliação; dipirona sem perguntar alergia
Aciona	Dor ≥7 (laranja) em ≤10 min; dor torácica/abdominal com red flag/cefaleia súbita: pelas fichas específicas — sem analgesia delegada antes da avaliação (dipirona simples permitida na dor abdominal — não mascara)
Registra	Escala inicial, fármaco/dose/via/hora, escala na reavaliação, efeito adverso

3.10 Rebaixamento / confusão / agitação / intoxicação / abstinência [04, 23, 31, 13]

Gatilho	Qualquer alteração do nível de consciência ou do comportamento
Faz	Glicemia, SpO₂, temperatura, FR, pupilas — antes de qualquer outra coisa (agitação nova com sinal vital anormal = orgânico); segurança (ambiente, saída, equipe, objetos); decúbito lateral se rebaixado; O ₂ se SpO ₂ <92%; embalagens/história com acompanhante em separado; etilista: preparar tiamina 300 mg IV (administrar por protocolo antes de qualquer glicose); CIWA-Ar na chegada e a cada 1 h se ≥10 em abstinência; de-escalação verbal (um interlocutor, tom calmo, oferecer água/escolhas); risco de suicídio: perguntar diretamente e não deixar só; CIATox 0800 722 6001 à mão
Não faz	Sedar sem prescrição; contenção mecânica sem prescrição (exceto emergência iminente com comunicação imediata ao médico — COFEN 427 — e checklist 3.15); deixar sozinho; dar VO a rebaixado; confrontar/ameaçar
Aciona	Imediato se Glasgow ≤12, FR <10, SpO ₂ <92%, convulsão, hipertermia, violência iminente, ingestão de agente de alta letalidade; ≤10 min nos demais
Registra	Glasgow, pupilas, glicemia, T, RASS, CIWA, substâncias/embalagens, hora da tiamina, de-escalação tentada, contenção (formulário)

3.11 Trauma, feridas, queimaduras, mordeduras e animais peçonhentos [34, 28, 27, 26]

Gatilho	Qualquer lesão
Faz	Trauma: colar cervical se mecanismo significativo/dor cervical/rebaixamento/≥65 a; compressão direta de sangramento → torniquete se não controla (anotar hora); imobilizar fraturas/luxações antes do RX; cinta pélvica (lençol) se mecanismo de alta energia com dor/instabilidade pélvica; 2 acessos calibrosos; aquecer; tétano: verificar cartão. Queimadura: retirar roupas/joias, água corrente à temperatura ambiente por 20 min (até 3 h do acidente; nunca gelo), cobrir com lençol limpo, aquecer o paciente, calcular SCQ (regra dos 9/palma — só 2º e 3º grau), química: irrigar ≥20–30 min. Mordedura: lavar com água e sabão por 15 min na chegada, antes do médico; anotar animal/situação; não suturar. Peçonhento: lavar, retirar garrote/anéis, membro em posição neutra, hora do acidente, foto do animal se seguro, TC à beira-leito (tubo seco) se serpente, criança <10 a com escorpião = laranja com reavaliação 30/30 min. Ferida simples: lavagem com SF/água e sabão, curativo; não suturar sem médico
Não faz	Gelo/pomadas caseiras/pasta de dente em queimadura; romper bolhas; suturar mordedura; retirar torniquete; remover corpo estranho impactado; dar VO a politraumatizado
Aciona	Imediato: instabilidade, sangramento não controlado, queimadura >10%/face/inalação/elétrica, envenenamento com sintomas, TCE com rebaixamento; ≤10 min: fratura deformada, ferida extensa, mordedura de face/mão, criança com escorpião
Registra	Mecanismo, hora, lavagem (hora/duração), torniquete (hora), SCQ, cartão de vacina, animal

3.12 Vômitos, diarreia e desidratação — planos A/B/C [06]

Gatilho	Diarreia/vômitos, especialmente em criança e idoso
Faz	Avaliar desidratação (olhos, lágrimas, boca, sede, prega, pulso — tabela A3 do Protocolo 06); peso; Plano A (sem desidratação): SRO após cada evacuação (<1 a: 50–100 mL; 1–10 a: 100–200 mL; adulto: à vontade) + orientação + zinco por protocolo (criança: 10 mg/dia <6 m; 20 mg/dia ≥6 m, 10–14 d) — a alta continua sendo médica; a enfermagem inicia e orienta; Plano B: TRO supervisionada: SRO 50–100 mL/kg em 4 h em colher/seringa a cada 1–2 min, reavaliar 30/30 min; vômitos: aguardar 10 min e retomar em volumes menores; preparar ondansetrona para prescrição; Plano C (grave): acesso/IO, preparar SF/Ringer 20 mL/kg, glicemia — médico imediato; precaução de contato; sinais de disenteria/sangue → amarelo/laranja
Não faz	Soro IV em quem tolera VO; antiemético/antidiarreico/antibiótico sem prescrição; suspender aleitamento; "jejum"
Aciona	Imediato: Plano C/letargia/<2 meses; ≤30 min: Plano B; sangue nas fezes; vômitos incoercíveis
Registra	Grau de desidratação, peso, volumes de SRO ingeridos/perdas, reavaliações

3.13 Febre, dengue e síndrome gripal [11, 06, 10]

Gatilho	Febre ou história de febre
Faz	Temperatura, FR, SpO ₂ , PA, TEC; dipirona/paracetamol por protocolo se T ≥38 com desconforto (adulto: dipirona 1 g ou paracetamol 750 mg; criança: 15 mg/kg); dengue suspeita (febre + 2 de: cefaleia, dor retro-orbitária, mialgia, artralgia, exantema, prostração — em período epidêmico): prova do laço, perguntar sinais de alarme (dor abdominal intensa, vômitos persistentes, sangramento, letargia, hipotensão postural), hidratação oral imediata (60 mL/kg/dia adulto), sem AINE/AAS , coletar hemograma se protocolo, notificação; síndrome gripal: máscara cirúrgica, isolamento, SpO ₂ (SRAG se <95%/dispneia), grupo de risco anotado; petéquias/púrpura + febre = vermelho (meningococcemia); <3 meses com febre = laranja; rigidez de nuca/confusão = laranja
Não faz	AINE/AAS na dengue suspeita ou criança com febre sem diagnóstico; antibiótico sem prescrição; banho frio/álcool
Aciona	Imediato: púrpura, choque, rebaixamento; ≤10 min: sinal de alarme de dengue, <3 meses, SRAG, imunossuprimido, T ≥39,5 com hipotensão
Registra	T, antitérmico (hora), prova do laço, sinais de alarme, notificação

3.14 Gestante, violência, saúde mental — acolhimento específico [35, 04, 15]

Gatilho	Gestante com queixa; suspeita/relato de violência; ideação suicida/crise
Faz	Gestante: PA ($\geq 140/90$ = amarelo; $\geq 160/110$ ou cefaleia/escotomas/epigastralgia/convulsão = laranja/vermelho), BCF se treinado, sangramento/perda de líquido/dor = laranja; DLE. Violência: sala reservada, sem o possível agressor, escuta sem julgamento, não fotografar sem consentimento, não lavar/trocar roupas antes da orientação médica na violência sexual (vestígios) — mas nunca atrasar o atendimento; iniciar ficha SINAN; acionar serviço social; violência sexual ≤ 72 h = laranja (relógio da PEP). Saúde mental: perguntar sobre ideação suicida diretamente; não deixar só; retirar meios; acolher; laranja se plano/tentativa
Não faz	Exame íntimo sem consentimento/médico; julgar; exigir BO; liberar criança/idoso com o suspeito; deixar pessoa com ideação sozinha
Aciona	Médico ≤ 10 min; serviço social; Conselho Tutelar (criança) conforme protocolo 35
Registra	Relato literal entre aspas, lesões descritas objetivamente, quem acompanha, comunicações feitas

3.15 Contenção mecânica — checklist (só em emergência, com médico acionado) [04]

Passo	Conduta
Antes	Tentativas de de-escalação registradas; medicação oferecida; risco iminente de dano a si/outros documentado; comunicação imediata ao médico (prescrição escrita em ≤ 30 min); equipe de 5 (1 fala, 4 membros); explicar ao paciente
Durante	Faixas próprias acolchoadas (nunca ataduras/lençóis/algemas); 4 pontos; decúbito dorsal, cabeça 30°, nunca ventral ; sem pressão em tórax/pescoço; retirar objetos; mínimo de tempo; medicação conforme prescrição
Vigilância	Profissional à vista; checar a cada 15 min : perfusão/pele dos membros, respiração/ SpO_2 , sinais vitais, hidratação, eliminações, conforto, sedação; alternar membros; oferecer água; reavaliação médica a cada 1 h; retirada assim que RASS $\leq +1$
Registro	Formulário de contenção: indicação, alternativas tentadas, horários (início, checagens, término), participantes, intercorrências, comunicação à família

4. Estrutura, kits e formulários da triagem

- **Na triagem:** esfigmomanômetro (manguitos adulto/obeso/pediátrico), oxímetro (sensor pediátrico), termômetro, glicosímetro com fitas, balança, régua de dor (numérica/faces/FLACC/PAINAD), fita de Broselow, cronômetro, cartazes: cores/tempos, sinais vitais por idade, NEWS2, FAST, discriminadores de dengue/sepse, doses das fichas 3.x por peso.
- **Kit de anafilaxia** (adrenalina 1 mg/mL x5, seringas 1 mL, agulhas 25x7/40x12); **kit de hipoglicemia** (glicose 50% x4, G10%, glucagon, açúcar/gel); **kit de crise** (diazepam, midazolam); **tiamina** (≥ 10 ampolas); **salbutamol pMDI + espaçadores** (adulto/pediátrico com máscara); SRO e zinco; dipirona/paracetamol/ibuprofeno VO e dipirona IV; O_2 com máscara não reinalante e cateter; colares cervicais; torniquete; água corrente para queimadura/mordedura; máscaras cirúrgicas.
- **Formulários:** ficha de triagem (com NEWS2, dor, cor, discriminador, conduta delegada, hora do acionamento); formulário de reavaliação; formulário Utstein; formulário de contenção; ficha SINAN; formulário CIWA-Ar; checklist diário de kits (assinado).
- **Aprovação e treinamento:** assinatura do Diretor Clínico e do RT de enfermagem; treinamento de 100% da equipe de triagem com avaliação prática (classificação de casos, cálculo de doses, uso de espaçador/adrenalina/DEA) antes da vigência; reciclagem semestral; auditoria mensal de 30 fichas.

4.1 Indicadores do protocolo de enfermagem (auditoria mensal)

Indicador	Meta
% de pacientes triados em ≤10 min da chegada com sinais vitais completos e cor registrada	≥90%
% de vermelhos/laranjas com médico à beira-leito no tempo da cor (hora registrada)	≥90%
% de rebaixamento/agitação/convulsão com glicemia em ≤5 min	100%
% de dor torácica com ECG em ≤10 min	≥90%
% de suspeita de AVC com LSN registrado	100%
% de anafilaxia com adrenalina IM em ≤5 min do reconhecimento	100%
% de dor ≥4 com analgesia delegada em ≤30 min e reavaliação registrada	≥85%
% de sepse suspeita com "hora zero" e culturas antes do ATB	≥90%
% de reavaliações no intervalo da cor (amostra)	≥80%
Sub-triagem (paciente verde/azul que evoluiu para vermelho/laranja em <2 h) e sobre-triagem — revisão de casos	Registrar; ≤5%
Contenções com checklist completo; eventos adversos de medicação delegada	100% / registrar
Retorno em 24-48 h reclassificado uma cor acima	≥90%

5. Pontos que exigem decisão institucional antes da aprovação

Tema	Posição proposta / decisão pendente
Sistema de classificação	Manchester exige licença e treinamento formal; a PNH/MS permite protocolo próprio de 4-5 níveis. Proposto: 5 cores com discriminadores derivados da série — decidir se adota Manchester licenciado ou este protocolo
Medicamentos delegados	Lei 7.498 permite prescrição de enfermagem em rotina aprovada pela instituição; a lista proposta (AAS na SCA, adrenalina IM, glicose/glucagon, tiamina, salbutamol, dipirona/paracetamol/ibuprofeno, SRO/zinco, diazepam/midazolam no EME ≥5 min com médico acionado, diclofenaco IM na cólica renal) deve ser aprovada item a item pelo Diretor Clínico e pelo RT de enfermagem , com registro no COREN se exigido
Benzodiazepínico no EME pela enfermagem	Alto impacto (t1 = 5 min) e risco de depressão respiratória — proposto apenas com médico já acionado, monitor e BVM à mão; decidir
AAS na dor torácica	Baixo risco e alto benefício; contraindicações a checar (alergia, sangramento, dissecação suspeita); decidir
DEA e choque pela enfermagem	Padrão BLS — sem controvérsia; garantir DEA/desfibrilador com modo automático
Coleta de culturas e lactato por protocolo laboratorial	Exige acordo com o laboratório para coleta sem requisição médica prévia ("pacote sepse"); pactuar
Acionamento direto da regulação (código AVC/IAM) pela enfermagem	Reduz tempo; exige pactuação com a CROSS/SAMU; decidir
Diclofenaco IM na cólica renal	Eficaz, mas IM tem riscos (Nicolau); preferir cetorolaco IV se houver médico em ≤10 min — decidir se mantém
Dose lock pediátrico	Todas as doses por peso devem ser conferidas contra a tabela institucional e a fita de Broselow; sem tabela afixada, não delegar medicação pediátrica

6. Referências

- Brasil. Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986 (exercício da enfermagem); Decreto nº 94.406/1987.
- Conselho Federal de Enfermagem. Resolução COFEN nº 661/2021 (classificação de risco); Resolução COFEN nº 736/2024 (Processo de Enfermagem); Resolução COFEN nº 427/2012 (contenção mecânica); Resolução COFEN nº 564/2017 (Código de Ética); Parecer sobre administração de medicamentos por protocolo institucional (COREN-SP, edição vigente).
- Brasil. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 2.048/2002 (Regulamento Técnico dos Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência). Ministério da Saúde. Acolhimento e classificação de risco nos serviços de urgência (Política Nacional de Humanização). Brasília, 2009. Portaria GM/MS nº 1.271/2014 (notificação compulsória).
- Grupo Brasileiro de Classificação de Risco. Sistema Manchester de Classificação de Risco: classificação de risco na urgência e emergência. 2ª ed. 2010 (3ª ed. 2018). Royal College of Physicians. National Early Warning Score (NEWS) 2. London, 2017.
- Protocolos médicos da série PS Natal Diegues (PS-ND-01 a 36), 2026 — em especial 01, 03, 04, 05, 06, 07, 12, 13, 14, 16, 23, 27, 28, 30, 31, 34, 35, 36, cujas doses e critérios esta ficha reproduz.
- American Heart Association. 2025 Guidelines for CPR and ECC — Basic Life Support. Sociedade Brasileira de Pediatria/ASBAI. Anafilaxia: atualização 2021 (adrenalina IM por protocolo). Global Initiative for Asthma. GINA 2026 (SABA com espaçador).

Felipe Ribeiro Toledo — Médico — CRM-SP 216.986

Responsável técnico pela elaboração